

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE FLUORUROS “FLUORACIONES”

Clínica Universitaria de Odontología

Antes de prescribir/ aplicar cualquier producto fluorado se debe evaluar el **riesgo de caries.**

1. BARNICES DE FLÚOR (menores de 6 años)

Producto: Duraphat® (NaF al 5%; 22600ppm)



Indicaciones:

1. Situaciones de riesgo de caries que afectan a toda la cavidad oral
 - Caries del biberón y caries de la primera infancia
 - Portadores de aparatología ortodóncica
2. Situaciones de riesgo de caries localizadas:
 - En molares que están erupcionando y que no se pueden sellar
 - En lesiones de caries, tanto incipientes como activas
 - Márgenes de restauraciones
 - En dientes afectados por Hipomineralización Incisivo-Molar (HIM) y otras lesiones del esmalte.

Técnica de aplicación:

- En toda la dentición: se realiza por cuadrantes y, si es posible, con aislamiento relativo con rollos de algodón.
 - Aplicación localizada: aislamiento relativo.
1. No es necesario realizar una profilaxis previa, pero sí se debe eliminar el exceso de placa, mediante cepillado y uso de hilo dental. Si no fuera suficiente, se pasarán unos pellets para retirar la placa restante.
 2. Secar bien los dientes con chorro de aire o con rollos de algodón (en caso de hiperestesia).
 3. Aplicar una fina capa de barniz con un pincel, tratando de introducirlo en las fosas y fisuras que no estén selladas, en los espacios interproximales y en el margen gingival. Se empleará especialmente en aquellas zonas del esmalte desestructuradas por las alteraciones del mismo.
 4. Entre las recomendaciones que debemos dar a los padres/tutores de los pacientes se encuentra la abstención de comer alimentos calientes y duros o abrasivos durante 12 horas. No se cepillará la zona en donde se ha aplicado barniz hasta el día siguiente.

Frecuencia de aplicación:

A criterio del profesional y según cada situación concreta y el riesgo de caries.

- a) En casos de HIM moderada /severa se aplicará cada **3-4 meses**.
- b) En el resto de las situaciones, podemos aplicarlo cada **6 meses**, coincidiendo con las revisiones semestrales que requieren estos pacientes.

2. GELES DE FLÚOR (mayores de 6 años)

Indicaciones:

Riesgo de caries moderado/alto.



Técnica de aplicación:

1. Se **secarán** los dientes mediante la jeringa de aire.
2. El paciente permanecerá sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante y abajo para evitar una ingesta accidental de gel.
3. No debe llenarse más del **40%** de cada cubeta, es decir, unos **2-2,5 ml** de gel.
4. Se utilizará la **aspiración** entre las dos cubetas durante todo el proceso.
5. Si el paciente no tolera mantener las dos cubetas simultáneamente, se colocará una después de la otra.
6. El tiempo mínimo será de **1 minuto**, pero se debe intentar mantener hasta alcanzar los **4 minutos** de exposición.
7. Se instruirá al paciente para que **escupa** todo el exceso de gel.
8. Si el paciente colabora, se pasará **el hilo dental** para que el gel de flúor alcance los **espacios interproximales**.
9. No debe desatenderse al paciente en ningún momento.
10. Se darán instrucciones para que **no se ingieran sólidos ni líquidos** en los siguientes **30-60 minutos**, ni **ningún lácteo** hasta el día siguiente.

Frecuencia de aplicación:

- a) En situaciones de **riesgo moderado** de caries: cada **6 meses**.
- b) En situaciones de **riesgo alto** de caries: se puede aplicar cada **3 meses**.

3. PROTOCOLO DE REMINERALIZACIÓN

Producto: MI Varnish



Material necesario

- Aislamiento relativo (algodones, aspiración y OptraGate).
- Pincel.
- Monodosis MI Varnish.

Procedimiento

1. Colocar aislamiento relativo (algodones, aspiración y opcionalmente abrebocas o OptraGate).
2. Limpia la superficie del diente con un cepillo de profilaxis.
3. Seca el diente.
4. Quitar la tapa de la monodosis.
5. Con un pincel, remover y agitar el barniz hasta que el contenido sea homogéneo.
6. Aplicar una película fina y uniforme sobre los dientes.
7. Retirar el aislamiento.
8. Indicaciones para el paciente: evitar alimentos duros, calientes o pegajosos; no cepillar, usar hilo o colutorios con alcohol durante 4 horas.

4. PROTOCOLO DE REMINERALIZACIÓN

Producto: GC MI Paste Plus (para uso domiciliario)



1. Lavarse los dientes y pasar el hilo dental antes de aplicar el producto.
2. Colocar una pequeña cantidad de MI Paste Plus en el dedo y friccionar el producto sobre los dientes de manera uniforme, incidiendo en las zonas más problemáticas.
3. Ayudarse con la saliva para que la pasta penetre entre los dientes.
4. Dejar actuar durante 2 minutos.
5. Escupir los restos del producto (NO enjuagar).
6. Evitar comer o beber después de realizar el tratamiento, debe ser lo último que se haga antes de ir a dormir.

5. PROTOCOLO DE REMINERALIZACIÓN

Producto: Clinpro XT Varnish.



Material necesario

- Aislamiento relativo (algodones, aspiración y OptraGate).
- Ácido ortofosfórico al 37%.
- Pincel.
- Clinpro XT Varnish.
- Espátula.
- Block mezcla.

Procedimiento

1. Colocar aislamiento relativo (algodones, aspiración y opcionalmente abrebocas o OptraGate).
2. Limpia la superficie del diente con un cepillo de profilaxis.
3. Grabar con ácido ortofosfórico al 37% durante 15 segundos y lavar.
4. Secar la superficie dental.
5. Dispensar la cantidad necesaria sobre el block de mezcla.
6. Mezclar el producto con una espátula antes de aplicar.
7. Aplicar el barniz sobre la zona afectada.
8. Polimerizar 20 segundos con lampara LED o 40 segundos con lámpara halógena.
9. Humedecer ligeramente.
10. Reaplicar cada 4-6 meses.

6. PROTOCOLO DE USO DE RESINA INFILTRADA

Producto: Icon®



1. Indicaciones de uso

La resina infiltrada ICON está indicada en los siguientes casos:

- **Lesiones cariosas incipientes:**
 - Lesiones de esmalte no cavitadas.
 - Lesiones proximales y vestibulares confinadas al esmalte.
- **Defectos estéticos:**
 - Manchas blancas post-ortodoncia.
 - Hipomineralizaciones superficiales no cavitadas.
 - Casos leves de fluorosis en superficies lisas.
- **Alternativa mínimamente invasiva** a la microabrasión o restauraciones convencionales en lesiones iniciales.

Contraindicaciones:

- Lesiones cavitadas.
- Caries activas avanzadas en dentina.
- Pacientes con mala higiene oral no controlada.

2. Procedimiento

A. Preparación

1. **Aislamiento absoluto** (con dique de goma) para evitar contaminación. Es fundamental que el campo de trabajo esté suficientemente seco.
2. **Limpieza de la superficie** con cepillo de profilaxis y pasta sin flúor.

B. Etapas del procedimiento

1. Grabado (Icon-Etch)

- Aplicar el gel de ácido clorhídrico al 15% durante **2 minutos** en la superficie afectada. El ácido elimina la capa superficial hipermineralizada.
- Enjuagar abundantemente con agua durante **30 segundos**.
- Secar la lesión en profundidad.

2. Deshidratación (Icon-Dry)

- Aplicar etanol al 99% durante **30 segundos**. Se usa para remover el agua almacenada en las microporosidades del cuerpo de la lesión y permitir la penetración de la resina en dichas microporosidades por capilaridad.
- Secar con aire.
- Evaluar: si aún se percibe lesión blanca, puede repetirse la etapa de grabado hasta **3 ciclos**.

3. Infiltración (Icon-Infiltrant)

- Aplicar la resina infiltrante durante **3 minutos**, ayudando con pincel o hilo dental (en proximales) para mejorar la penetración.
- Retirar exceso con hilo dental o aplicadores.
- Fotopolimerizar **40 segundos**.

4. Segunda aplicación (opcional, recomendada)

- Reaplicar resina infiltrante durante **1 minuto**.
- Retirar excesos.
- Fotopolimerizar nuevamente **40 segundos**.

C. Finalización

- Retirar aislamiento.
- Ajustar y pulir la superficie tratada.
- Instrucciones de higiene oral al paciente.